사 업 명
(1) 공공기관 임무중심 감염병연구 다부처협력사업(R&D) (6634-365)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	질병관리청	국립보건연구원 국립감염병연구소		090	091
명칭					보건	보건의료

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	6600	6634	365
명칭	보건의료연구관리	국가 보건의료연구 인프라 구축	공공기관임무중심감염병연구 다부처협력사업(R&D)

□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 "○" 표시)

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
○						

□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
공공기관임무중심 감염병연구다부처 협력사업(R&D)	-	-	-	2,246	1,300	1,300	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300
· 백신개발 연구협력	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375
· 치료제개발 연구협력	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285
· 연구인프라 공동구축	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300
· 연구활동비 (360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(공공기관임무중심감염병연구다부처협력사업(R&D))** (과기부-질병청)공공연구기관 간 백신·치료제 공동연구 및 국가 통합 라이브러리 구축, 공동 연구인프라 구축

  * (평시)감염병 대응기술 공동개발 → (위기시)100/200일 백신·치료제 개발전략 연계

- **(내역사업1 백신개발 연구협력)** 신변종 감염병 대유행 대비 신속한 백신개발을 위한 국가 백신 라이브러리 구축, 과기부 산하 출연(연)과 질병청의 개별 연구성과 공유 및 연구협력을 통한 백신 항원 라이브러리 구축 연구 고도화

- **(내역사업2 치료제개발 연구협력)** 신종감염병 대유행 대비 신속한 치료제개발을 위해 연구기관 간 협력체계 고도화를 통한 치료후보 물질/정보 라이브러리 구축, 공공연구

기관협력 우선순위 감염병 치료물질 선제적 확보체계 마련

- **(내역사업3 연구인프라 공동구축)** 질병청↔과기부 공공연구기관 간 미래감염병 신속 대응을 위한 자원·정보공유 및 공동연구, 신규인프라 구축 및 이어달리기 체계 마련

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시

구분	주요내용
과학기술 기본법	**제1조(목적)** 이 법은 과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 나아가 국민의 삶의 질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지함을 목적으로 한다
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	**제1조(목적)** 이 법은 국민 건강에 위해(危害)가 되는 감염병의 발생과 유행을 방지하고, 그 예방 및 관리를 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 국민 건강의 증진 및 유지에 이바지함을 목적으로 한다. **제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)** ② 국가 및 지방자치단체는 감염병의 예방 및 관리를 위하여 다음 각 호의 사업을 수행하여야 한다. 6. 감염병에 관한 조사·연구 9. 감염병 관리정보 교류 등을 위한 국제협력
보건의료기술 진흥법	**제2조(정의)** ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 8. "보건의료기술 연구개발사업"이란 보건의료기술의 연구·개발(다음 각 목의 법률에 따른 연구·개발을 포함한다)을 위하여 예산 또는 기금으로 지원하는 사업을 말한다. 바. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」

② 추진경위

ㅇ (추진배경) 신종감염병 대유행 대비 중장기계획('23.5월)에 따른 "(5-2)신·변종 감염병 대응 R&D 지원체계 강화"에 후속조치로 기획된 사업

- 질병청-과기부가 주관하는 각 사업의 성과를 개발단계, 개발주체 간 연계를 주관하고 이어달리기 체계를 고도화할 주체가 부재한 상황으로 각 부처별 R&D성과물의 고도화와 현장 활용을 위해 다부처협력사업을 기반으로 공공연구기관 간 임무중심 연구협력체계 구축 필요
- 본 사업을 통해 100, 200일 이내 백신·치료제 신속개발 기반 마련을 목적으로 하며, 이를 위해 평시에 공공연구기관 통합 후보물질 라이브러리(플랫폼, 평가법 등)를 구축하고 위기시에 신속하게 대응하기 위한 연구임

* (첨단백신개발플랫폼) mRNA 백신의 항원발현에 직결되는 구조체·전달체 기술 개발

* (신속개발·평가기술) 감염병 표적 항원 라이브러리를 구축하고, 후보물질 대상 약리·독성 신속

평가법을 통한 전임상 단계 원스톱 진입 역량 확보

ㅇ (국정과제) 사회1-5-4, “넥스트 팬데믹 대비 위기 대응 및 필수의약품 공급안정”을 위해 “필수백신 및 신종·미해결 감염병 치료제 개발로 보건안보 역량 강화” 추진

- (백신) ❶국가예방접종·❷공공안보 백신 자급화, ❸우선순위·❹미해결 감염병 백신 개발, 백신 항원후보물질 라이브러리 구축 등 개발 가속화
- (치료제) 인공지능(AI), 고속탐색기술(HTS) 및 대용량 데이터 분석 등 新기술 활용 신종·미해결 감염병 치료제 개발(항체치료제, 항생제 내성 치료제 등)

ㅇ (관련 공약)

《 관련 주요 공약 》

■ **(AI 등 신산업집중육성) 제약·바이오 산업에 대한 국가투자와 책임성을 강화**

⇨ **넥스트 팬데믹 대비 위기 대응 인프라 구축 및 국제협력 확대·강화**

- mRNA<합성항원기술 등 차세대 백신 플랫폼 연구개발 지원 확대
- 넥스트 팬데믹 대응 거버넌스 구축 및 감염병 대응 체계 고도화
- 감염병 공동연구 확대 및 공중보건위기 대응 국제협력 확대 강화

□ **주요내용**

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음
- 사업기간 : `26~`28년(3년)
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	1,300

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연
- 사업시행주체 : 한국보건산업진흥원, 한국연구재단
- 사업 수혜자 : 공공연구기관 및 대학, 병원 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조.융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조.피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
백신개발 연구협력	출연	한국보건산업진흥원, 한국연구재단	375	100	
치료제개발 연구협력	출연	한국보건산업진흥원, 한국연구재단	285	100	
연구인프라 공동구축	출연	한국보건산업진흥원, 한국연구재단	640	100	

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ 공공기관임무중심감염병연구다부처협력사업(R&D)(신규) → (2026) 1,300백만원

① 백신개발 연구협력: ('25) 0→ ('26) 375백만원, 순증

- 질병청-과기부 산하 감염병공공연구기관의 백신 공동개발과 국가 통합 라이브러리 구축을 위해 375백만원 편성('26년 신규, 순증)

- (산출) 1개 과제 × 1,000백만원 × 9/12개월 × 0.5(부처투자비율) = 375백만원

② 치료제개발 연구협력: ('25) 0→ ('26) 285백만원, 순증

- 질병청-과기부 산하 감염병공공연구기관의 치료후보물질개발과 국가 통합 라이브러리 구축을 위해 285백만원 편성('26년 신규, 순증)

- (산출) 1개 과제 × 760백만원 × 9/12개월 × 0.5(부처투자비율) = 285백만원

③ 연구인프라 공동구축: ('25) 0→ ('26) 640백만원, 순증

- 질병청↔과기부 공공연구기관 간 미래감염병 신속대응을 위한 자원공유 및 공동연구 협력, 신규 인프라 구축 및 성과이어달리기 체계 마련을 위해 640백만원 편성('26년 신규, 순증)

- (산출) 1개 과제 × 1706.7백만원 × 9/12개월 × 0.5(부처투자비율) = 640백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
내역1. 백신개발 연구협력									
백신 후보물질 자원 비축 건수(건)	목표	-	-	-	-	3	컨소시엄 구성기관 협력 백신 공동연구 성과 후보물질 및 평가정보를 목표치로 설정 *기존 개발이력이 없는 마버그열, 크레미안콩고출혈열 등 고위험감염병 타겟임을 감안하여 기준 목표치를 1개로 설정하고 연차별로 건수 확대	참여기관으로부터 통합 비축된 백신후보물질 개수	라이브러리 운영기관의 기탁현황 제출을 측정대상으로 함
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
백신 후보물질 정보 비축 건수(건)	목표	-	-	-	-	20		참여기관으로부터 통합 비축된 백신후보물질 DB 개수	라이브러리 운영기관의 기탁현황 제출을 측정대상으로 함
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
내역2. 치료제개발 연구협력									
우수 치료제 후보물질 자원 비축건수(건)	목표	-	-	-	-	8	참여기관 효능평가 및 교차검증 결과 기반 우수 치료 후보물질 발굴 건수	참여기관으로부터 비축된 치료제 후보물질 개수	치료제 발굴 기관의 보유현황 제출을 측정대상으로 함
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

치료제 후보물질 정보 비축건수(건)	목표	-	-	-	-	200	참여기관 협력으로 항체, 화합물, 천연물 신규물질 탐색 및 신기술 기반 스크리닝 등을 통해 발굴된 연간 치료 후보물질 신규 효능평가정보를 목표치로 설정	참여기관으로부터 통합 비축된 치료제후보물질 DB 개수	라이브러리 운영기관의 기탁현황 제출을 측정대상으로 함
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
내역3. 연구인프라 공동구축									
병원체 자원·정보·네트워크 현황판 구축률(%)	목표	-	-	-	-	100	컨소시엄 참여기관 보유 병원체 자원·정보·네트워크 현황판 플랫폼 구축을 목표로 참여기관 전체 인프라를 100으로 설정하고 연차별 단계적 통합	참여기관 보유 병원체 인프라를 항목*별로 구분하여 측정** *항목: 자원시설, 정보 수집·네트워크 **현황판 통합 항목 / 참여기관 보유 항목 X 100%	국가병원체자원은행의 현황판을 기준으로 측정
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
현황판 활용률(%)	목표	-	-	-	-	30	국가병원체자원은행 분양건수 (24년 기준 등재 7,944주, 분양 2,948건으로 약 30% 활용률) *전년도 현황판 구축률 30%를 고려	민간, 대학, 병원 등의 병원체 자원·정보·네트워크 활용 건수/현황판 구축 x 100%	국가병원체자원은행의 현황판을 기준으로 측정
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당없음

2022	
2023	
2024	
2025	

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

부처	예상성과(최종)	기대효과
질병청	- 감염병 대응용 우선순위 백신·치료제 후보물질 확보 및 전략적 관리 - 실시간 전파력·치명률 등을 반영한 맞춤형 대응 백신·치료제 개발 가능 - 국가 감염병 위기 대응체계 내 임상 이전 핵심 후보물질 포트폴리오 확보	①연구개발 중복 방지 - 각 부처가 개별적으로 추진해오던 백신·치료제 개발 사업 간 기술·성과 중복 최소화 - 후보물질 통합관리로 효율성 제고 ② 신속 대응체계 마련 - 팬데믹 등 위기상황 시, 부처 간 신속한 후보물질 공유 및 공동 대응 체계 확보 ③ R&D 성과 확산 기반 구축 - 후보물질 라이브러리를 통한 공공연구기관·민간기업 간 기술이전 촉진 - 범부처의 공동 기획 기반 마련 ④ 민간 활용도 제고 - 통합된 후보물질 정보는 스타트업·제약사 등 민간연구개발 활용 가능 ⑤ 국제 경쟁력 확보 - WHO 등 국제기구와의 정보공유 및 협력을 통한 글로벌 감염병 대응 생태계 참여 확대
과기부	- 범부처 공동 활용 가능한 R&D 기획 및 연구인프라 표준화 - 신기술 기반의 백신/치료제 후보물질 고속 스크리닝 플랫폼 구축 - 바이오 데이터 기반의 AI예측모델 고도화 및 고속평가시스템 개발 - 기초연구성과 및 보유기술 성과확산 (기술사업화, 현장적용)	

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

- 백신개발 연구협력

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
질병관리청	=> (375백만원)	한국보건산업진흥원 (375백만원)	=> (375백만원)	공공연구기관 중심 컨소시엄
과기정통부	=> (375백만원)	한국연구재단 (375백만원)	=> (375백만원)	공공연구기관 중심 컨소시엄

- 치료제개발 연구협력

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
질병관리청	=> (285백만원)	한국보건산업진흥원 (285백만원)	=> (285백만원)	공공연구기관 중심 컨소시엄
과기정통부	=> (285백만원)	한국연구재단 (285백만원)	=> (285백만원)	공공연구기관 중심 컨소시엄

- 치료제개발 연구협력

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자·사업수행자
질병관리청	=> (640백만원)	한국보건산업진흥원 (640백만원)	=> (640백만원)	공공연구기관 중심 컨소시엄
과기정통부	=> (640백만원)	한국연구재단 (640백만원)	=> (640백만원)	공공연구기관 중심 컨소시엄

8) 각종 평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당없음

사 업 명
(1) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업(R&D) (6634-345)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	질병관리청	국립보건연구원		090	091
명칭					보건	보건의료

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	6600	6634	345
명칭	보건의료연구관리	국가 보건의료연구 인프라 구축	국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업(R&D)

□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 "○" 표시)

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○		○			

□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	(B-A)/A
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		
국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업(R&D)	21,755	23,934	23,934	12,135	12,135	△11,799	△49.3

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	21,755	21,755	21,755 [20,584]	-	-	23,934	23,934	23,934 [23,934]	23,934	23,934 [23,934]	-	-	12,135
· 바이오 데이터뱅크 구축·운영	19,001	19,001	19,001 [18,132]	-	-	22,729	22,729	22,729 [22,729]	22,729	22,729 [22,729]	-	-	11,580
· 사업단 운영	2,754	2,754	2,754 [2,452]	-	-	1,205	1,205	1,205 [1,205]	1,205	1,205 [1,205]	-	-	555
○ 비목별 분류(합계)	21,755	21,755	21,755 [20,584]	-	-	23,934	23,934	23,934 [23,934]	23,934	23,934 [23,934]	-	-	12,135
· 연구개발활동비등 (360-05)	21,755	21,755	21,755 [20,584]	-	-	23,934	23,934	23,934 [23,934]	23,934	23,934 [23,934]	-	-	12,135
○ 기능비목별 분류(합계)	21,755	21,755	21,755 [20,584]	-	-	23,934	23,934	23,934 [23,934]	23,934	23,934 [23,934]	-	-	12,135
· 바이오 데이터뱅크 구축·운영	19,001	19,001	19,001 [18,132]	-	-	22,729	22,729	22,729 [22,729]	22,729	22,729 [22,729]	-	-	11,580
-연구개발활동비등(360-05)	19,001	19,001	19,001 [18,132]	-	-	22,729	22,729	22,729 [22,729]	22,729	22,729 [22,729]	-	-	11,580
· 사업단 운영	2,754	2,754	2,754 [2,452]	-	-	1,205	1,205	1,205 [1,205]	1,205	1,205 [1,205]	-	-	555
-연구개발활동비등(360-05)	2,754	2,754	2,754 [2,452]	-	-	1,205	1,205	1,205 [1,205]	1,205	1,205 [1,205]	-	-	555

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

○ (국가 통합 바이오 빅데이터 구축) 참여자 동의 기반 검체(혈액·소변 등)를 확보*하고, 임상·유전체 및 공공데이터 등을 통합·개방하기 위한 R&D 인프라 구축

* 1단계('24～'28년) 77.2만명 모집(예타 기준 6,065.8억원)

- (내역① 바이오 데이터뱅크 구축·운영) 개인 중심으로 통합된 바이오 빅데이터 구축 및 동의·수집·보호·활용체계 마련
- (내역② 사업단 운영) 사업 기획, 평가 및 성과관리 등 사업 운영 관리

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

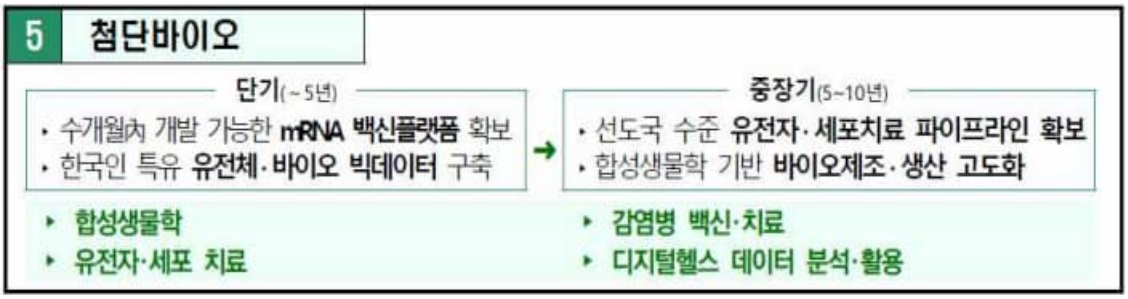
① 법령상 근거 및 조항 적시

○ 과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진)

제11조(국가연구개발사업의 추진) ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다. <개정 2014. 5. 28.>

② 추진경위 - 사업 시작년도, 추진배경, 부처별 중점과제, 대통령 공약사항 등

지원근거	○ **국정과제 32-2** - **의료 AI·제약·바이오헬스 강국 실현 / 의료AI 등 디지털 헬스케어 혁신성장 체계 구축** ○ 제5차 과학기술기본계획('23~'27), Ⅳ. 중점 육성기술(전략기술)

	2 12대 국가전략기술 분야 및 50개 세부 중점기술 - 한국인 특유 유전체·바이오 빅데이터 구축  ㅇ 제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24~'28) **중점기술 4 디지털·헬스 데이터 분석·활용** □ 기술개발, 핵심R&D ㅇ 신약·의료기기 개발, 정밀의료 실현을 위한 AI 활용 촉진 및 **바이오 빅데이터 구축 지원** - 참여자의 동의를 기반으로 검체(혈액, 소변 등)를 확보, 임상·유전체 데이터를 생산, 공공데이터와 라이프로그를 수집·연계하여 R&D 인프라인 한국형 바이오 빅데이터 및 데이터뱅크 구축 * 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 ('24~'28, '24년 171억원) ㅇ 신성장 4.0프로젝트('23.1. 기재부) - 12 (바이오 혁신) 바이오 파운드리, 바이오 데이터뱅크 구축 **※ '25년 추진계획('25.3월)** ㅇ 데이터뱅크 대국민 홍보 등을 통한 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 참여자 모집 본격화('25), 양질의 연구자원* 축적 및 내실화 * 유전체 및 오믹스 데이터 생산, 공공데이터 등 2차 자료 연계 등 ㅇ 바이오헬스 신시장창출전략('23.2.) - ❸ (데이터뱅크) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 및 개방 : 임상정보·유전체 데이터, 공공데이터 및 라이프로그 등을 통합한 바이오 빅데이터 구축·개방 ㅇ 「데이터경제 활성화 방안」('23.11., 기재부) - '공공-임상-유전체-라이프로그' 데이터를 개인단위로 연결하여 구축
추진경위	ㅇ (시범사업) 2.5만 명 규모 시범사업 추진('20~22), 임상·유전체 데이터 구축·개방('23.6월~) → 연구재단의 시범사업 평가 결과 "우수" ㅇ (예타 추진) 예비타당성조사 신청 및 통과('23.6월) ㅇ (본사업 전환) 사업단 구성 및 정책지정·지정공모과제 수행기관 등 거버넌스 구축('24.4월~), 참여자 모집 개시('24.12월~) ㅇ (특정평가) 예타 계획변경을 위하여 총사업비 약 515억원(범부처, '26~'28)* 증액('25.5월) * 참여자 인센티브 364억, 모집기관 인건비 현실화 등 86억, 홍보비 65억

□ **주요내용**

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 580,579백만원
- 사업기간 : ‘24~‘28년
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	21,755	23,934	12,135

- 기타 : 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연
- 사업시행주체 : (주관부처) 보건복지부
  (참여부처) 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 질병관리청
  (전문기관) 한국보건산업진흥원
  (사 업 단) 국가통합바이오빅데이터구축사업단
- 사업 수혜자 : 희귀·중증질환자, 참여자, 연구자, 기업 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조.피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
바이오 데이터뱅크 구축·운영	출연	한국보건 산업진흥원	11,580 백만원	100	「보건의료기술진흥법」 제3조(기술개발의 보호 · 육성) 및 제7조(연구개발사업 전문기관의 지정) 등 「국가연구개발혁신법」 제22조(연구개발사업 전문기관의 지정)
사업단 운영			555 백만원	100	

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 바이오 데이터뱅크 구축·운영

: (2025 본예산) 22,729백만원 → (2026) 11,580백만원, 11,149백만원 감액

- 개인 중심으로 통합된 바이오 빅데이터 구축 및 동의·수집·보호·활용체계 마련(11,580백만원)
- (산출) 총 44개 과제(계속) x 2,668백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 지원 비율)

※ 부처별 지원비율 : (복지부) 42.37%, (과기부) 34.25%, (산업부) 13.51%, **(질병청) 9.87%**

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
19,001 백만원	**계속과제1. 참여자 모집 기관 관리 및 홍보 : 69백만원** - 1개 과제 x 320백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 69백만원 **계속과제2. 참여자 모집 및 임상정보 검체수집 : 6,024백만원** - 38개 과제 × 740.8백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 6,024백만원 **계속과제3. 데이터뱅크 구축·운영 : 2,301백만원** - 1개 과제 × 10,751백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 2,301백만원 **계속과제4. 바이오빅데이터 플랫폼 구축·운영 : 4,300백만원** - 1개 과제 × 20,092백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 4,300백만원 **계속과제5. 인제자원제작 및 검체운송 : 2,723백만원** - 1개 과제 × 12,722백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 2,723백만원 **계속과제6. 유전체 등 오믹스 데이터 생산 분석 : 7,291백만원** - 1개 과제 × 34,068백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 7,291백만원 **계속과제7. 데이터 기반 연구 네트워크 지원 : 21백만원** - 1개 과제 × 100백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 21백만원	11,580 백만원	**계속과제1. 참여자 모집 기관 관리 및 홍보 : 246백만원** - 1개 과제 x 2,500백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 246백만원 **계속과제2. 참여자 모집 및 임상정보 검체수집 : 3,070백만원** - 38개 과제 × 818.4백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 3,070백만원 **계속과제3. 데이터뱅크 구축·운영 : 1,127백만원** - 1개 과제 × 11,413백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 1,127백만원 **계속과제4. 바이오빅데이터 플랫폼 구축·운영 : 2,264백만원** - 1개 과제 × 22,969백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 2,264백만원 **계속과제5. 인제자원제작 및 검체운송 : 1,297백만원** - 1개 과제 × 13,150백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 1,297백만원 **계속과제6. 유전체 등 오믹스 데이터 생산 분석 : 3,556백만원** - 1개 과제 × 36,044백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 3,556백만원 **계속과제7. 데이터 기반 연구 네트워크 지원 : 20백만원** - 1개 과제 × 200백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 20백만원

② 사업단 운영

: (2025 본예산) 1,205백만원 → (2026) 555백만원, 650백만원 감액

- 사업 기획, 평가 및 성과관리 등 사업 운영 관리를 위한 사업단 운영비(555백만원)
- (산출) 총 1개 과제(계속) 5,626백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 지원 비율)

※ 부처별 지원비율 : (복지부) 42.37%, (과기부) 34.25%, (산업부) 13.51%, **(질병청) 9.87%**

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
1,205 백만원	**계속과제8. 사업단 운영 : 1,205백만원** - 1개 과제 × 5,630백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 1,205백만원	555 백만원	**계속과제8. 사업단 운영 : 555백만원** - 1개 과제 × 5,626백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 555백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
참여자 모집 건수 (단위 : 천건)	목표	-	-	-	206	398	1단계('24~'28) 목표 모집인원에 대해 연차별 목표치 설정	∑(검체 수집을 완료한 참여자 수(누적))	바이오 빅데이터 플랫폼 상 등재 완료된 참여자 수 측정
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
통합 바이오 데이터 구축률 (단위 : %)	목표	-	-	-	70	73	데이터 통합·연계 소요 기간을 고려해 '25년 70%로 설정 및 연도별 3%p 상향	(∑연계데이터 생성 참여자 수) / (∑사업 동의 참여자 수)×100	데이터뱅크 시스템상 동의 유지 참여자 측정
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
참여자 관리 시스템 구축 공정률 (단위 : %)	목표	-	-	38	60	60	구축 일정에 따라 산출 ('26 구축 완료)	인프라 구축(HW) 공정률(누적)×가중치 + 시스템 개발(SW) 공정률(누적)×가중치	공정별 예산 투입 및 성과 달성도 측정 가능한 문서 (감리수행 결과보고서 등)
	실적	-	-	38	-	-			
	달성도	-	-	100	-	-			
바이오 빅데이터 플랫폼 구축 공정률 (단위 : %)	목표	-	-	24	62	100	구축 일정에 따라 산출 ('26 구축 완료)	인프라 구축(HW) 공정률(누적)×가중치 + 시스템 개발(SW) 공정률(누적)×가중치	공정별 예산 투입 및 성과 달성도 측정 가능한 문서 (감리수행 결과보고서 등)
	실적	-	-	23.9	-	-			
	달성도	-	-	99.7	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2024	· 사업단 개소 및 정책지정과제 수행기관* 선정('24.4월) * (데이터뱅크) 한국보건의료정보원 / (바이오빅데이터 플랫폼) 한국과학기술정보연구원 / (유전체 등 데이터 생산 분석) 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터 · 공모과제* 공고 개시 및 선정('24.5월~) * 참여자 모집 및 임상정보·검체 수집, 인체자원 제작 및 검체 운송
2025	· 국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업 공동사업관리지침 배포('25.3월) · 예타 계획 변경을 위한 특정평가를 통한 추가 예산(범부처 515억, '26~'28) 확보('25.5월)

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 개조식으로 작성, <u>건 별로 계량적 수치 제시</u>

○ 한국형 통합 바이오 빅데이터 구축('24~'32)을 통한 맞춤의료 실현 - 77.2만명(질환자 18.7만명 일반인 58.5만명)의 바이오 분야 핵심 연구자원 확보('24~'28) - 임상정보·유전체 데이터, 공공데이터 등을 통합한 바이오 빅데이터 개방('26~)

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지

□ 예비타당성조사 통과('23.6월)

- 조사기관 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP)
- 조사결과 : 대안시행(B/C 비율 : 0.69)
  * 예비타당성조사 결과 100만 명 규모의 9년 사업을 2단계(5년+4년)로 분할하여 1단계 사업을 5년간 ('24～'28년, 6,065.8억) 77.2만 명 규모로 우선 추진
- 사업기간 : '24년 ~ '28년(5년)
- 총사업비 : 6,065.8억원

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

사업 추진절차	내용
세부과제 선정·공고	○ (지정과제) 정책지정과제 지정 ○ (공모과제) 세부추진계획 확정・공고 * 사업안내서, 과제제안요구서(RFP) 포함
↓	
공모과제 신청·접수 (제안서 제출)	○ 연구개발계획서 작성・신청(신청기관) ○ 연구개발계획서 접수
↓	
공모과제선정 평가	○ 과제선정 평가계획 수립 ○ 사전검토 → 선정평가(평가위원회 개최, 서면 및 발표평가 등) ○ 선정결과 확정(운영위원회) 및 주무부처 보고
↓	
협약체결	○ 총괄협약 : 전문기관 ↔ 사업단 ○ 과제협약 : 사업단 ↔ 주관연구기관(참여기관 포함)
↓	
진도관리	○ 마일스톤 기반 진도관리, 연차 점검
↓	
단계평가 (해당하는 경우)	○ 평가계획 수립 ○ 단계보고서 평가(평가위원회) ○ 평가결과 확정(운영위원회) 및 주무부처 보고
↓	
최종평가	○ 평가계획 수립 ○ 최종보고서 평가(평가위원회) ○ 평가결과 확정(운영위원회) 및 주무부처 보고
↓	
과제 추적조사	○ 추적조사계획 수립 ○ 종료된 과제들에 대해 종료 후 5년차까지 매년 추적조사 실시 ○ 추적조사 결과 주무부처 및 전문기관에 보고

8) 각종 평가

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적

- ‘24년 국회 상임위원회 부대의견(‘25 예산)
  - · (서미화 의원) 질병관리청 등 4개 부처는 참여자를 대상으로 한 인센티브 제공 및 홍보 강화 등 구체적인 모집 전략을 바탕으로 한 성과관리 강화방안을 마련할 것
  - · (이수진 의원) 사업내역 간 추진실적의 차이가 큰 바, 암환자 및 희귀질환자 대상 사업 확대 필요성 등 적정한 사업계획 조정 및 성과관리 철저 필요
- ‘25년 국회 상임위원회 시정요구(‘24 결산)
  - · (서영석 의원) - 질병관리청은 국가통합바이오빅데이터사업단 운영비 2024년 집행 잔액을 국고로 반납하고 향후 재발방지 방안을 마련할 것

2) 문제점 지적에 대한 후속조치

구 분	반영 내용
‘24년 국회 상임위원회 (서미화 의원, ‘25예산)	- (부대의견) 질병관리청 등 4개 부처는 참여자를 대상으로 한 인센티브 제공 및 홍보 강화 등 구체적인 모집 전략을 바탕으로 한 성과관리 강화방안을 마련할 것 - 반영사항 · 참여자 모집기관 대상 공고 및 협약완료 · 참여자 확보를 위해 소통·채널 확대, 인센티브 제공, 대국민 홍보 등의 구체적 전략수립 및 추진 진행중
‘24년 국회 상임위원회 (이수진 의원, ‘25예산)	- (부대의견) 사업내역 간 추진실적의 차이가 큰 바, 암환자 및 희귀질환자 대상 사업 확대 필요성 등 적정한 사업계획 조정 및 성과관리 철저 필요 - 반영사항 · ‘25년도부터 희귀질환자 및 암환자 모집군 대상 참여자 모집 확대예정 · 운영위원회 의결을 통해 희귀질환 및 암질환 등 주요 질환에 대한 연차별 세부 모집 목표치 조정 등을 통해 차질없는 사업 추진예정
‘25년 국회 상임위원회 (서영석 의원, ‘24결산)	- (시정요구/제도개선) 질병관리청은 국가통합바이오빅데이터 사업단 운영비 2024년 집행잔액을 국고로 반납하고 향후 재발 방지 방안을 마련할 것 - 반영사항 · 2024년 사업단 운영비 집행잔액 반납 완료(8.19.) · 지적 사항 재발 방지를 위해 향후 집행잔액에 대해 즉시 반납하도록 사업 관리 강화

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이.전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2024	21,755	-	21,755	-	-	-	21,755	21,755	100.0	100.0	-	-
2025. 12월 말	23,934	-	23,934	-	-	-	23,934	23,934	100.0	100.0	-	-

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2024	- 해당없음
2025	- ‘25년 국회 상임위원회(서영석 의원, ‘24결산) · (시정요구/제도개선) 질병관리청은 국가통합바이오빅데이터사업단 운영비 2024년 집행잔액을 국고로 반납하고 향후 재발방지 방안을 마련할 것. · (반영사항) 2024년 사업단 운영비 집행잔액 반납 완료(8.19.) 및 지적 사항 재발 방지를 위해 향후 집행잔액에 대해 즉시 반납하도록 사업 관리 강화

□ 2025년 이·전용 등 세부내역 : 해당사항 없음

사 업 명
(1) 국가통합바이오빅데이터구축사업II(R&D) (6634-352)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	질병관리청	미래의료연구부	0	090	091
명칭					보건	보건의료

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	6600	6634	352
명칭	보건의료연구관리	국가 보건의료연구 인프라 구축	국가통합바이오빅데이터구축사업II(R&D)

□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 "○" 표시)

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○		○	○		

□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	(B-A)/A
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		
국가통합바이오빅데이터구축사업II(R&D)	174.7	1,245	1,245	19,949	19,949	18,704	1,502.3

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	1,157	1,157	174.7 [174.7]	767.8	214.5	1,245	2,012.7	1,482.3 [1,482.3]	1,245	1,154.8 [1,154.8]	45.3	485.1	19,949
·바이오 빅데이터 인체유래물 바이오뱅킹	1,157	1,157	174.7 [174.7]	767.8	214.5	1,245	2,012.7	1,482.3 [1,482.3]	1,245	1,154.8 [1,154.8]	45.3	485.1	19,949
○ 비목별 분류(합계)	1,157	1,157	174.7 [174.7]	767.8	214.5	1,245	2,012.7	1,482.3 [1,482.3]	1,245	1,154.8 [1,154.8]	45.3	485.1	19,949
·시험연구비(210-13)	213	213	63.3 [63.3]		149.7	320	320	320	320	320			319
·관리용역비(210-15)	104	104	90.9 [90.9]		13.1	150	150	134.8	150	134.8		15.2	150
·일반연구비(260-01)						770	770	695	770	695	45.3	29.7	230
·기본조사설계비(420-01)	332	332	10 [10]	287.8	34.2		287.7	256.2				31.6	32
·실시설계비(420-02)	497	497		480	17		480	71.3				408.7	409
·공사비(420-03)													84
·감리비(420-04)													16
·시설부대비(420-05)	11	11	10.5 [10.5]		0.5	5	5	5	5	5			9
·자산취득비(430-01)													18,700
○ 기능비목별 분류(합계)	1,157	1,157	174.7 [174.7]	767.8	214.5	1,245	2,012.7	1,482.3 [1,482.3]	1,245	1,154.8 [1,154.8]	45.3	485.1	19,949
· 바이오 빅데이터 인체유래물 바이오뱅킹	1,157	1,157	174.7 [174.7]	767.8	214.5	1,245	2,012.7	1,482.3 [1,482.3]	1,245	1,154.8 [1,154.8]	45.3	485.1	19,949
-시험연구비(210-13)	213	213	63.3 [63.3]		149.7	320	320	320	320	320			319
-관리용역비(210-15)	104	104	90.9 [90.9]		13.1	150	150	134.8	150	134.8		15.2	150
-일반연구비(260-01)						770	770	695	770	695	45.3	29.7	230
-기본조사설계비(420-01)	332	332	10 [10]	287.8	34.2		287.7	256.2				31.6	32

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
-실시설계비(420-02)	497	497		480	17		480	71.3				408.7	409
-공사비(420-03)													84
-감리비(420-04)													16
-시설부대비(420-05)	11	11	10.5 [10.5]		0.5	5	5	5	5	5			9
-자산취득비(430-01)													18,700

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- **(국가통합바이오빅데이터구축사업Ⅱ)** 국가경쟁력을 책임질 바이오 분야 핵심 연구자원 확보 및 질환 원인 규명·미래 의료기술 개발로 환자 편익 증대 등을 위해 국가통합 바이오 빅데이터 구축사업에서 개인 동의 기반으로 수집한 인체유래물을 저장관리할 수 있는 바이오뱅크 시설 구축 및 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업에서 수집한 인체유래물을 안정적으로 관리하여 보건의료 R&D 연구 지원

- **(바이오 빅데이터 인체유래물 바이오뱅킹)** 국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업 추진에 따른 100만 명분 인체자원 저장 및 관리를 위한 저장시설 증축, 임시저장시설 운영 및 인체자원 관리

2) 사업개요

□ **사업근거 및 추진경위**

① 법령상 근거 및 조항 적시

○ 과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진)

> 제11조(국가연구개발사업의 추진) ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다. <개정 2014. 5. 28.>

② 추진경위

지원근거	○ **국정과제 25-4(바이오 헬스·디지털 헬스케어 혁신/ 보건의료 빅데이터 구축으로 정밀의료 활성화)** - 백만 명 규모 임상·유전체·공공 보건의료 정보 등을 기반으로 국가 통합 바이오 빅데이터 구축·개방 통한 정밀의료 연구개발 촉진 ○ **과학기술기본법 제11조의 1, 제5차 과학기술기본계획(`23~`27), 제3차 국가생명연구자원 관리 활용 기본계획('20~'25), 제3차 보건의료기술육성기본계획(`23~`27)** - **과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진)** ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다. - **제5차 과학기술기본계획(`23~`27):** 중점 육성기술(전략기술), **12대 핵심 국가전략기술(첨단바이오/한국인 특유 유전체·바이오빅데이터 구축)** - **제3차 국가생명연구자원 관리 활용 기본계획('20~'25)**: 수요자 맞춤형 바이오 소재 활용 촉진(전략2), 관계 부처가 협력하여 14대 소재 클러스터 육성(2-1) - **제3차 보건의료기술육성기본계획(`23~`27)**: 바이오헬스 강국 도약을 위한 신산업 육성(전략3), 디지털 헬스케어 혁신/빅데이터 기반의 바이오헬스 경쟁력 강화(7-1) ○ **비상경제민생회의(`22.7., VIP보고)** - 정밀의료 인프라 확보 위한 보건의료 빅데이터 구축 - 정밀의료 연구개발의 핵심 인프라인 '국가 통합 바이오 빅데이터' 구축(100만 명 목표)으로 국민건강 증진, 산업적 활용 기반 강화 ○ **비상경제민생회의(`22.10., VIP보고)** - 환자에게 최적의 치료 제공을 위한 바이오 빅데이터 구축·활용 추진 ○ **인구구조 변화와 대응방안(`22.12., 기재부)** - 범부처 기획으로 100만 명 규모 임상정보, 유전체 데이터, 개인건강정보 등 정밀의료 연구자원 구축 추진 ○ **신성장 4.0프로젝트(`23.1. 기재부)** - 12 (바이오 혁신) 바이오 파운드리, 바이오 데이터뱅크 구축 ○ **서비스 산업 혁신전략(`23.1. 기재부)** - 100만 명 규모의 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 추진 ○ **바이오헬스 신시장창출전략(`23.2., VIP보고)** - ❸ (데이터뱅크) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 및 개방 : 임상정보·유전체 데이터, 공공데이터 및 라이프로그 등을 통합한 바이오 빅데이터 구축·개방 ○ **제3차 제약바이오산업 육성지원 종합계획('23.3.)** - ❶ 국가 통합 바이오 빅데이터 구축으로 신약개발·정밀의료 실현 : 100만명 규모 유전체 바이오 빅데이터 구축으로 신약 개발, 정밀의료 등 질병 극복·산업발전 연구에 활용 ○ **제1차 의료기기산업 육성지원 종합계획 ('23.3.)** - ❷ (빅데이터 구축·활용) 새로운 의료기술 발굴 및 개발을 통한 혁신 가속화를 위해 보건의료 빅데이터 활용 인프라 조성(복지·과기·산업·질병청) : (바이오 빅데이터) 100만명 규모 임상·유전체 데이터 기반의 통합 바이오 빅데이터 구축으로 질병극복·산업발전 연구에 활용 ○ **첨단산업 클러스터 육성방안(`23.6., VIP보고)** - 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 및 개방 ○ **「데이터경제 활성화 방안」('23.11., 기재부)** - 국가 통합 바이오 빅데이터 구축시, '공공-임상-유전체-라이프로그' 데이터를 개인단위로 연결하여 구축 ○ **「24차 민생토론회」- 첨단바이오 육성방안('24.3.26., VIP보고)**

	- 부처간 협업을 통해 국가 바이오 데이터 플랫폼을 구축하고, 의료데이터 활용이 활성화 될 수 있도록 적극 지원 ㅇ **바이오·헬스 데이터플랫폼 협의체(`24.4.16., 과기부)** - 공공 및 민간에서 개별적으로 구축(구축 중)한 바이오·헬스 데이터를 연계·활용하여 성과창출을 논의하기 위한 산·학·연·병·정 협의체 운영
추진경위	ㅇ **(추진배경)** 의료 패러다임의 변화와 신성장동력으로서 바이오 빅데이터 중요성 대두, 데이터 파편화 및 개인정보 활용 제한 등으로 부가가치 창출 한계 - 신약개발 등 정밀의료 및 산업적 연구 활성화를 위한 바이오 빅데이터 구축을 통해 R&D 인프라로 활용 필요 ㅇ **(시범사업 수행)** 과학기술장관회의에서 범부처 과제로 국가 바이오 빅데이터 구축 결정, 본 사업에 앞서 시범사업 추진·종료('20~'22년) - 총 2.5만명 규모의 임상·유전체 데이터 구축·개방('23.6월~) ㅇ **(예비타당성조사)** 부처 대면회의(`22.9.23.)와 총괄위원회 자문(`22.10.31.)을 통해 예타 대상사업 선정(`22.11.1.), 예타 조사 결과 확정('23.6.29)* * 9년 사업을 2단계(5+4)로 분할, 1단계('24~'28년) 77.2만명 규모 사업 추진

□ **주요내용**

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 62,441백만원
- 사업기간 : 2024년~2028년
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	1,157	1,245	19,949

- 기타 : 인체자원 저장시설 증축 규모
  - ○ 부지 16,529 ㎡, 연면적 5,143.42 ㎡ (지하1층, 지상3층 예정)

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 질병관리청
- 사업 수혜자 : 희귀·중증질환자, 참여자, 국내 보건의료 연구자, 기업 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조・융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

< 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업II(R&D) : (2025) 1,245 → (2026) 19,949백만원, (+1,502.3%)>

① 바이오 빅데이터 인체유래물 바이오뱅킹 : ('25) 1,245백만원 → ('26) 19,949백만원, +1,502.3%

- 대규모 국가사업인 '국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업' 추진에 따른 인체자원 저장시설 증축 및 임시저장시설 운영을 위해 '26년 19,949백만원 반영

- (산출)

1. 인체자원 저장시설 구축 : ('25) 5백만원 → ('26) 19,250백만원(+19,245백만원)

* 국립중앙인체자원은행 인체자원관리시설 증축 : ('25년) 5백만원 → ('26년) 19,250백만원

· 대형자동화초저온저장장비: 37,400백만 x 2대 x 50%(선금) = 18,700백만원

· 인체자원은행 기본실시설계: 32백만(기본설계)+409백만(실시설계) = 441백만원

· 인체자원은행 증축(계약): 84백만(건축) + 16백만(감리) = 100백만원

· 설계적정성 평가비: 4.5백만 x 2회 = 9백만원

2. 인체자원 저장시설 운영 : ('25) 700백만원 → ('26) 699백만원(△1백만원)

* 인체자원 관리용역 : 1개과제 × 150백만 × 12/12개월 = 150 백만원

* 인체자원 저장시설 운영 : 319백만원

· 액체질소 구매비: 액체질소 150,000kg/월 × 178원/kg × 12/12개월 = 319백만원

* 인체자원 정보관리시스템 유지보수 : 1개사업 x 230백만 x 12/12개월 = 230백만원

< 산출근거 >

구 분		산정비용
HuBIS_Sam 기능개선 (자원관리) 인건비	참여자관리시스템, 플랜트급 저장장비와 데이터 연계를 위한 데이터베이스 구조 변경	34.8백만원
	기능 개선(대량 자원입고)	
	디자인 개선 개선(대량 자원입고)	
HuBIS_Tracker 기능개선 (기탁이력관리) 인건비	참여자관리스스템, 플랜트급 저장장비와 데이터 연계를 위한 데이터베이스 구조 변경	30.7백만원
	기능 개선(대량 자원입고)	
	디자인 개선 개선(대량 자원입고)	
제경비	직접인건비의 140~150%	95백만원
기술료	(직접인건비 + 제경비)의 20~40%	48백만원
부가가치세		21백만원
합 계		**230백만원**

* 운영 가능한 최소 기준으로 책정, 본 운영 개시('23.11월 ~)

** 본 운영 이후, 안정적 성능유지에 필요한 추가 서버(WEB, WAS, DB 1조), 개발·검증 서버 추가, 민간 인체유래물은행 HuBIS_Sam 클라우드 서비스(시범) 등 대응 비

3. (신규)인체자원 품질관리 : ('25) 540 → ('26) 0 (순감)

ㅇ 2025년도 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

'25년 예산		'26년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
1,245,000	○ 시험연구비(**210-13) : 320,000천원** 가. 인체자원 임시저장시설 운영 (320,400천원) ・ 액체질소 구매비 : 26700천원/1개월×12개월 =320,000 ○ **관리용역비(210-15) : 150,000천원** 가. 인체자원 임시저장시설 운영(150,000천원) ・ 인체자원 관리용역 1개 과제 150,000천원 x 12/12 개월=150,000천원 ○ **일반연구비(260-01) : 770,000천원** 가. 인체자원 임시저장시설 운영(230,000천원) ・ 인체자원 정보관리시스템 유지보수 1개과제 × 230,000천원 x 12/12 개월=230,,000천원 나. 인체자원 품질관리(540,000천원) ・ 인체자원 품질관리 1개과제 × 540,000천원 x 12/12 개월=540,000천원	19,949,000	○ 시험연구비(**210-13) : 319,000천원** 가. 인체자원 임시저장시설 운영 (319,000천원) ・ 액체질소 구매비 : 26600천원/1개월×12개월 =319,000 ○ **관리용역비(210-15) : 150,000천원** 가. 인체자원 임시저장시설 운영(150,000천원) ・ 인체자원 관리용역 1개 과제 150,000천원 x 12/12 개월=150,000천원 ○ **일반연구비(260-01) : 230,000천원** 가. 인체자원 임시저장시설 운영(230,000천원) ・ 인체자원 정보관리시스템 유지보수 1개과제 × 230,000천원 x 12/12 개월=230,,000천원 ○ **기본조사설계비(420-01) : 32,000천원** 가. 인체자원 저장시설 구축 ・ 기본조사설계비 32,000천원 ○ **실시설계비(420-02) : 409,000천원** 가. 인체자원 저장시설 구축 ・ 실시설계비 409,000천원 ○ **공사비(420-03) : 84,000천원** 가. 인체자원은행 증축(계약) ・ 증축 공사비 84,000천원 ○ **감리비(420-04) : 16,000천원** 가. 인체자원은행 증축(계약) ・ 증축 감리비 16,000천원 ○ **시설부대비(420-05) : 9,000천원** 가. 인체자원 저장시설 설계평가 ・ 설계적정성평가 x 4,00천원 x 2 = 9000천원 ○ **자산취득비(430-01) : 18,700,000천원** 가. 인체자원 저장장비 도입 ・ 18,700,000천원 x 1대 = 18,700,000천원

4) 사업효과

□ **사업영향, 산출물 성과지표 등**

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
국립중앙인체자원은행 저장시설 증축공정율 (단위: %)	목표			4%	4.5%	5%	국립중앙인체자원은행 저장시설 증축공정율을 목표치로 선정	(누적투자액/총사업비)x100	예산집행현황 (디브레인)
	실적			4.3%	-	-			
	달성도			107.5%	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2024	- 총사업비 대상등록('24.1월) - 국립중앙인체자원은행 인체자원 관리시설 증축 공사 조달청 맞춤형서비스 체결('24.2월) - 국립중앙인체자원은행 인체자원 관리시설 증축 기본계획 고시('24년 5월) - 국립중앙인체자원은행 인체자원 관리시설 증축 공공건축심의('24년 6월) - 임시저장시설 접수실 및 저장실 구축('24년 8월) - 국립중앙인체자원은행 인체자원 관리시설 설계용역 공고 및 공모안 접수('24년 8월) - 국립중앙인체자원은행 인체자원 관리시설 설계용역 착수('24년 9월) 및 계획설계 완료('24년 12월)
2025	- 「총사업비 관리지침」 규정에 따라 설계용역 낙찰차액 발생으로 총사업비 감액(58,033 → 58,020백만원) ('25년 1월) - 중간설계완료('25년 5월) 및 설계적정성 검토(VE포함) 완료('25년9월) - 총사업비 조정 결과 통보, 물가변동·연약지반처리·소방방재시설 강화에 대한 4,421백만원 증액 (58,020백만원→) ('25년 11월) - 교통영향평가 사전심의 및 실시설계 착수('25년 11월)

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업에서 수집한 인체유래물 연구자원을 안정적으로 저장 ·관리할 수 있는 저장시설 구축 및 운영을 통한 바이오뱅크 고도화
- 국가경쟁력을 책임질 바이오 분야 핵심 연구자원 확보 및 제공으로 질환 원인 규명 및 미래 의료기술 개발로 환자 편익 증대

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지

□ 예비타당성조사 통과('23.6월)

- 조사기관 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP)
- 조사결과 : 대안시행(B/C 비율 : 0.69)

* 예비타당성조사 결과 100만 명 규모의 9년 사업을 2단계(5년+4년)로 분할하여 1단계 사업을 5년간('24~'28년, 6,065.8억) 77.2만 명 규모로 우선 추진

- 사업기간 : '24년 ~ '28년(5년)
- 총사업비 : 국고 6,065.8억 원

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역

- 총사업비 관리 대상 사업인 경우 작성

□ **총사업비 정보**

(단위: 억원)

연도	사업기간	2022까지 기투자액	2023	2024	2025	2026	2027이후 투자계획	계
사업비	2024~2028	-	-	8.4	0.05	192.5	409.09	628.95

□ **총사업비 변경내역(변경일자 및 규모, 변경사유)**

(단위: 억원)

구분	변경연도	총사업비		사업기간		변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도	
최초	2024		58.033	2024	2028	
(1)차 변경	2025		58.02	2024	2028	설계비 낙찰차액 감액
(2)차 변경	2025		62.441	2024	2028	물가변동, 소방방재시설 등 반영
2026년도			192.5	2024	2028	

7) 사업 집행절차

- **바이오 빅데이터 인체유래물 바이오뱅킹 내역사업** : 질병관리청 직접수행

업무제목 (담당)	내용
계약요청 (사업부서)	예산확보, 사업계획, 제안요청서 등을 작성하여 계약부서로 계약을 요청
입찰공고 (계약부서)	나라장터 공고 및 제안서 접수
제안서평가 (사업부서)	기술평가실시 기술+가격점수로 순위결정 기술협상 개시

계약체결 (계약부서)	1. 계약상대자에게 계약필요서류 제출 안내 및 접수 2. 계약체결, 지출원인행위, 계약체결 결과통보
사업진행 (사업부서, 계약부서)	1. 착수보고, 연구진행사항 점검 2. 선금지급 3. 사업결과 확인 4. 완수확인승인 및 검사결과 통보
대금지급 (계약부서)	1. 완수금 지급요청(사업부서) · 검사조서 및 완수확인서의 완료일자는 같아야 함 2. 대금지출요청서 제출(사업부서) 3. 지출결의(지출담당)

8) 각종 평가

1) 국회 상임위 지적

○ 총사업비 협의전 예타 결과를 이용하여 적정설계비에 추가편성된 263백만원 감액 및 추진시기 고려 인체자원 운영시설 운영 9개월에서 6개월로 단축 필요(상임위, 24예산)

2) 국회 예결위 부대의견 지적

○ 총사업비 협의전 예타 결과를 이용하여 적정설계비에 추가편성된 263백만원 감액 및 추진시기 고려 인체자원 운영시설 운영 9개월에서 6개월로 단축 필요(예결위, 24예산)

3) 문제점 지적에 대한 후속조치

○ 적정 설계비 초과분 263백만원 감액 및 인체자원 운영시설 운영비 3개월분 158백만원 감액

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이.전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액 (예상)	불용액 (예상)
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2024	1,157		1,157				1,157	174.7	15.1	15.1	767.8	214.5
2025. 12월 말	1,245		1,245	767.8			2,012.8	1,482.3	119.1	73.6	45.3	485.1

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- 해당사항없음
2023	- 해당사항없음
2024	- 인체자원 저장시설 증축을 위한 설계비 767.8백만원 이월 및 214.5백만원 불용
2025	- 해당사항없음

□ 2025년 이.전용 등 세부내역 : 해당사항없음

사 업 명
(1) 헬스케어 이종데이터 활용체계 및 인공지능 개발(R&D) (6634-331)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	질병관리청	국립보건연구원	0	090	091
명칭					보건	보건의료

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	6600	6634	331
명칭	보건의료연구관리	국가 보건의료연구 인프라 구축	헬스케어 이종데이터 활용체계 및 인공지능 개발(R&D)

□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 "○" 표시)

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
		○				

□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○						

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	(B-A)/A
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		
헬스케어 이종데이터 활용체계 및 인공지능 개발(R&D)	4,564	4,932	4,932	4,622	4,622	△310	△6.3

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	5,012	5,072	4,564	48	460	4,932	4,980	4,904	4,932	4,856	-	76	4,622
· 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용	4,509	4,569	4,171	48	350	3,280	3,328	3,320	3,280	3,272	-	8	2,952
· 시험연구인력지원	503	503	393	-	110	452	452	384	452	384	-	68	470
· 인공지능 연구지원	-	-	-	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-	1,200
○ 비목별 분류(합계)	5,012	5,072	4,564	48	460	4,932	4,980	4,904	4,932	4,856	-	76	4,622
· 상용임금(110-03)	417	417	333	-	84	374	374	326	374	326	-	48	388
· 일반수용비(210-01)	12	12	7	-	5	12	12	12	12	12	-	-	12
· 임차료(210-07)	20	20	17	-	3	20	20	20	20	20	-	-	20
· 복리후생비(210-12)	5	5	3	-	2	5	5	3	5	3	-	2	5
· 시험연구비(210-13)	130	130	126	-	4	104	104	104	104	104	-	-	104
· 관리용역비(210-15)	60	60	59	-	1	60	60	59	60	59	-	1	60
· 사업추진비(240-01)	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1
· 일반연구비(260-01)	3,786	3,846	3,542	48	256	4,283	4,331	4,324	4,283	4,276	-	7	3,955
· 고용부담금(320-09)	81	81	57	-	24	73	73	55	73	55	-	18	77
· 자산취득비(430-01)	500	500	419	-	81	-	-	-	-		-	-	-
○ 기능비목별 분류(합계)	4,932	4,980	4,564	48	460	4,932	4,980	4,904	4,932	4,856	-	76	4,622
· 헬스케어 연구데이	4,509	4,569	4,171	-	350	3,280	3,328	3,320	3,280	3,272	-	8	2,952

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
터 인공지능 활용													
- 일반수용비(210-01)	12	12	7	-	5	12	12	12	12	12	-	-	12
- 임차료(210-07)	20	20	17	-	3	20	20	20	20	20	-	-	20
- 시험연구비(210-13)	130	130	126	-	4	104	104	104	104	104	-	-	104
- 관리용역비(210-15)	60	60	59	-	1	60	60	59	60	59	-	1	60
- 사업추진비(240-01)	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1
- 일반연구비(260-01)	3,786	3,846	3,542	48	256	3,083	3,131	3,124	3,083	3,076	-	7	2,755
- 자산취득비(430-01)	500	500	419	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-
· 시험연구인력지원	503	503	393	-	110	452	452	384	452	384	-	68	470
- 상용임금(110-03)	417	417	333	-	84	374	374	326	374	326	-	48	388
- 고용부담금(110-03)	5	5	3	-	2	73	73	55	73	55	-	18	77
- 복리후생비(110-03)	81	81	57	-	24	5	5	3	5	3	-	2	5
· 인공지능 연구지원	-	-	-	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-	1,200
- 일반연구비(260-01)	-	-	-	-	-	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-	1,200

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (목적) 디지털 기술 기반의 실사용 헬스케어 이종데이터* 활용을 위한 데이터 수집 및 분석체계 구축, 인공지능 개발 및 코호트 기반 멀티모달 인공지능 학습용 데이터 구축
  * 전자의무기록 자료, 영상 자료, 디지털 기기 및 웨어러블 기기 데이터, 멀티오믹스 자료 등
- (내용)
  · (헬스케어 연구데이터 인공지능 활용) 기존 개별 병원 중심의 단편적 데이터 수집을 벗어나 실사용 데이터 기반, 디지털 기술을 접목한 질환별 포괄적인 헬스케어 이종데이터 수집, 정제, 표준화 및 이를 기반으로 한 인공지능 연구 수행
  · (시험연구인력지원) R&D 과제 수행 및 연구행정 지원을 위한 전문 연구인력(공무직, 기간제, 박사 후 연구원) 인건비 지원
  · (인공지능 연구지원) 코호트 기반 수집·생산된 헬스케어 데이터의 활용 증대를 위해 인공지능 학습용 데이터 발굴·구축·공개 및 클라우드 기반 연구 플랫폼 구축·지원

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 보건의료기술진흥법 제3조(기술개발의 보호·육성)

제3조(기술개발의 보호・육성) 정부는 보건의료기술의 진흥을 위한 연구개발 활동과 보건신기술을 장려하고 보호・육성하기 위한 정책을 마련하여 시행하여야 하며, 이에 필요한 비용을 지원할 수 있다.

- 보건의료기술진흥법 제4조(보건의료기술육성기본계획의 수립)

제4조(보건의료기술육성기본계획의 수립) ① 정부는 보건의료기술을 개발・촉진하기 위하여 5년마다 보건의료기술육성기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 수립하고 이를 추진하여야 한다.
② 보건복지부장관은 관계 중앙행정기관의 계획을 종합하여 기본계획안을 작성하고 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의(이하 "국가과학기술자문회의"라 한다)의 심의를 거쳐 이를 확정한다.
③ 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 보건의료기술의 방향과 목표
2. 보건의료기술의 국내외 환경 분석
3. 중장기 중점 기술개발 전략
4. 보건의료기술의 진흥을 위한 중장기 투자계획
5. 보건의료기술 인력의 수급(需給) 및 육성 방안
6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 보건의료기술의 개발에 중요한 사항
④ 보건복지부장관은 관계 중앙행정기관의 전년도 실적 및 다음 연도 계획을 토대로 연도별 시행계획(이하 "시행계획"이라 한다)을 수립하여 국가과학기술자문회의에 보고하여야 한다.
⑤ 보건복지부장관은 기본계획과 시행계획을 수립할 때 제6조에 따른 보건의료기술정책심의위원회에 보고하고 의견을 들을 수 있다.
⑥ 보건복지부장관은 기본계획과 시행계획을 수립하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 중앙행정기관의 장에게 자료를 요청할 수 있다.

- 보건의료기술진흥법 제5조(보건의료기술 연구개발사업의 추진)

제5조(보건의료기술 연구개발사업의 추진) ① 정부는 기본계획을 효율적으로 추진하기 위하여 보건의료기술 연구개발사업(이하 "연구개발사업"이라 한다)을 수행한다.
② 보건복지부장관은 연구개발사업으로 연도별・분야별 연구과제를 선정하여 다음 각 호의 기관이나 단체 등과 협약을 맺어 연구하게 할 수 있다. 이 경우 제4호의 기관 중 법인이 아닌 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표와 협약을 맺을 수 있다.
1. 국・공립 연구기관
2. 「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 연구기관
3. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
4. 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업부설연구소
5. 「민법」이나 다른 법률에 따라 설립된 법인인 연구기관

6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 보건의료기술 분야의 연구기관 또는 단체
③ 제2항에 따른 연구에 필요한 비용은 정부 또는 정부 외의 자의 출연금이나 기업의 기술개발비로 충당한다.
④ 보건복지부장관은 연구개발사업을 추진하기 위하여 제2항에 따른 연구를 수행하는 기관이나 단체 등에 출연금을 지급할 수 있다.
⑤ 보건복지부장관은 제2항에 따라 연구과제를 선정하여 협약을 맺거나 제3항 및 제4항에 따른 출연금을 지급할 때 특정 기관 또는 단체 등에 편중되지 아니하도록 노력하여야 한다.
⑥ 제2항에 따른 연구과제의 선정 방법 및 협약의 체결 방법과 제3항 및 제4항에 따른 출연금의 지급·사용·관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

- 과학기술기본법 제7조(과학기술기본계획)

제7조(과학기술기본계획) ① 정부는 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향을 설정하고 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의(이하 "과학기술자문회의"라 한다)의 심의를 거쳐 확정하여야 한다.
② 과학기술정보통신부장관은 5년마다 제1항에 따른 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향을 반영하고 관계 중앙행정기관의 과학기술 관련 계획과 시책 등을 종합하여 과학기술기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 세우고 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정하여야 한다.
③ 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 과학기술의 발전목표 및 정책의 기본방향
2. 과학기술혁신 관련 산업정책, 인력정책 및 지역기술혁신정책 등의 추진방향
3. 과학기술투자의 확대
4. 과학기술 연구개발의 추진 및 협동·융합연구개발 촉진
4의2. 미래유망기술의 확보
5. 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 등의 과학기술혁신 역량의 강화
6. 연구개발성과의 확산, 기술이전 및 실용화의 촉진, 기술창업의 활성화
6의2. 과학기술에 기반을 둔 성장동력의 발굴·육성
6의3. 과학기술을 활용한 삶의 질 향상, 경제적·사회적 현안 및 범지구적 문제의 해결
7. 기초연구의 진흥
8. 과학기술교육의 다양화 및 질적 고도화
9. 과학기술인력의 양성 및 활용 증진
10. 과학기술지식과 정보자원의 확충·관리 및 유통체제의 구축
11. 지방과학기술의 진흥
12. 과학기술의 국제화 촉진
13. 남북 간 과학기술 교류협력의 촉진
14. 과학기술문화의 창달 촉진
15. 민간부문의 과학기술혁신 촉진
15의2. 과학기술혁신의 촉진을 위한 제도나 규정의 개선
15의3. 과학기술에 기반을 둔 지식재산의 창출·보호·활용의 촉진과 그 기반의 조성
15의4. 성별 등 특성을 고려하고 사회적 가치를 증진하기 위한 과학기술의 구현
16. 그 밖에 대통령령으로 정하는 과학기술진흥에 관한 중요 사항
④ 관계 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 기본계획에 따라 연도별 시행계획을 세우고 추진하여야 한다.

⑤ 과학기술정보통신부장관은 매년 제4항에 따른 해당 연도 시행계획과 전년도 추진실적을 종합하고 점검하여 과학기술자문회의의 심의를 거쳐야 하며, 이에 관한 세부 사항은 대통령령으로 정한다.
⑥ 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 과학기술 관련 계획을 세울 때에는 기본계획에 따라야 한다.
⑦ 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 중・장기 정책목표와 방향을 설정하거나 기본계획을 세우기 위하여 필요하면 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 기업・교육기관・연구기관의 장, 과학기술 관련 기관・단체의 장에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다.
⑧ 과학기술정보통신부장관은 기본계획을 국회에 보고하여야 한다.

- 과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진)

제11조(국가연구개발사업의 추진) ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다.

② 추진경위

- (정부연구개발 투자방향) 바이오헬스 산업의 핵심분야 기술·산업혁신 지원 및 공익적 연구개발 투자를 강화하고, 연구성과의 산업화 촉진을 위한 전주기 연구개발 지원
- 질병관리청 개청 시, 바이오헬스 분야 인공지능 연구 전담부서 신설('20.9)
- '헬스케어 이종데이터 활용체계 및 인공지능 개발' 신규 사업 추진('22.)
- '국정과제 25. 바이오·디지털헬스 글로벌 중심국가 도약' 포함('22.)
- 질병관리청 주요정책과제 '3-2-1. 미래의료 기술 혁신을 위한 연구 및 인프라 강화' 추진('23.)
- '국정과제 32. 의료 AI·제약·바이오헬스 강국 실현' 포함('25.)

□ **주요내용**

① 사업규모

- 총사업비 : 20,290백만원(※총사업비 관리 대상 아님)
- 사업기간 : 2022.~2026.
- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	3,000	2,724	5,012	4,932	4,622

- 기타 : 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행
- 사업시행주체 : 질병관리청 국립보건연구원
- 사업 수혜자 : 일반국민, 산 · 학 · 연 · 병 연구자 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조・융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

ㅇ 헬스케어 이종데이터 활용체계 및 인공지능 개발(R&D)

: (2025 본예산) 4,932백만원 → (2026) 4,622백만원, 310백만원 감액

- (편성) 헬스케어 이종데이터 수집·정제·표준화 및 이를 기반으로 한 인공지능 연구 수행, 기 구축 코호트 기반 인공지능 학습용 데이터 구축·공개를 위해 예산 편성
- (산출) 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 2,952백만원
  시험연구인력지원 470백만원
  인공지능 연구지원 1,200백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
4,932 백만원	○ **상용임금(110-03) : 374,586천원** 가. 시험연구인력지원 (374,586천원) ・ 기본급 : 9명x12/12개월x31,158천원=280,426천원 ・ 수당 : 9명x12/12개월x10,462천원=94,160천원 ○ **일반수용비(210-01) : 11,599천원** 가. 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 (11,599천원) ・ 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 : 1식x11,599천원=11,599천원 ○ **임차료(210-07) : 20,000천원** 가. 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 (20,000천원) ・ 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 : 1식x20,000천원=20,000천원 ○ **복리후생비(210-12) : 4,500천원** 가. 시험연구인력지원 (4,500천원) ・ 복리후생비 : 9명x500천원=4,500천원 ○ **시험연구비(210-13) : 104,083천원** 가. 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 (104,083천원) ・ 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 : 1식x104,083천원=104,083천원 ○ **관리용역비(210-15) : 60,000천원** 가. 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 (60,000천원) ・ 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 : 1식x60,000천원=60,000천원 ○ **사업추진비(240-01) : 1,000천원** 가. 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 (1,000천원) ・ 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 : 1식x1,000천원=1,000천원 ○ **일반연구비(260-01) : 4,283,000천원** 가. 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 (3,083,000천원) ・ 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 : 1식x3,083,000천원=3,083,000천원 나. 인공지능 연구지원 (1,200,000천원) ・ 인공지능 연구지원 : 1식x1,200,000천원=1,200,000천원 ○ **고용부담금(320-09) : 73,232천원**	4,622 백만원	○ **상용임금(110-03) : 388,633천원** 가. 시험연구인력지원 (388,633천원) ・ 기본급 : 9명x12/12개월x32,154천원=289,385천원 ・ 수당 : 9명x12/12개월x11,028천원=99,248천원 ○ **일반수용비(210-01) : 11,835천원** 가. 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 (11,835천원) ・ 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 : 1식x11,835천원=11,835천원 ○ **임차료(210-07) : 20,000천원** 가. 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 (20,000천원) ・ 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 : 1식x20,000천원=20,000천원 ○ **복리후생비(210-12) : 4,500천원** 가. 시험연구인력지원 (4,500천원) ・ 복리후생비 : 9명x500천원=4,500천원 ○ **시험연구비(210-13) : 104,083천원** 가. 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 (104,083천원) ・ 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 : 1식x104,083천원=104,083천원 ○ **관리용역비(210-15) : 60,000천원** 가. 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 (60,000천원) ・ 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 : 1식x60,000천원=60,000천원 ○ **사업추진비(240-01) : 1,000천원** 가. 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 (1,000천원) ・ 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 : 1식x1,000천원=1,000천원 ○ **일반연구비(260-01) : 3,955,000천원** 가. 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 (2,755,000천원) ・ 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용 : 1식x2,755,000천원=2,755,000천원 나. 인공지능 연구지원 (1,200,000천원) ・ 인공지능 연구지원 : 1식x1,200,000천원=1,200,000천원 ○ **고용부담금(320-09) : 76,949천원**

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
	가. 시험연구인력지원 (73,232천원) · 4대보험 기관부담금 : 상용임금x11.25%=42,085천원 · 퇴직급여적립금 : 상용임금x8.33%=31,147천원		가. 시험연구인력지원 (76,949천원) · 4대보험 기관부담금 : 상용임금x11.47%=44,576천원 · 퇴직급여적립금 : 상용임금x8.33%=32,373천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
헬스케어 데이터 인공지능 기법 개발 적용률 (단위: %)	목표	60	63	66	69	72	'22년 신규 성과지표 목표를 60%로 설정하고 매년 이전년도 대비 5% 상향하는 것으로 설정함	헬스케어 데이터를 활용한 인공지능 기법·분석 적용 건수(누적) / 인공지능 기법·분석 개발 건수(누적) × 100	본 사업에서 수행한 연구과제 성과물 관련 문서 등
	실적	100	100	100	-	-			
	달성도	166.7	158.7	151.5	-	-			
연구용 헬스케어 데이터 구축률 (단위: %)	목표	70	75	80	85	90	민간 부분을 대상으로 조사한 '공공데이터의 오류율 5%'를 고려하여 2단계 사업의 최종 목표 95%를 기준으로, '22년 최초 목표치를 70%로 산정하고 매년 5%씩 증가시키는 것으로 설정함	신규 데이터 정제·표준화 건수 / 신규 생산·수집 데이터 건수 × 100	본 사업에서 수행한 연구과제 성과물 관련 문서 등
	실적	70.8	83.5	91.1	-	-			
	달성도	101.1	111.4	113.9	-	-			

헬스케어·인공지능 성과 확산 지수 (단위: 점)	목표	3	3	5	5	5	R&D의 경우 투입예산에 따라 성과목표가 변동될 수 있으므로 예산 대비 성과를 측정하였으며, 0.1점/억 기준으로 매년 목표치를 산정함. 당해연도 R&D 예산 감액시 최소 전년도의 목표치를 달성하고, 증액되면 0.1점/억을 기준으로 목표치 상향 고려. 따라서 ’26년 목표치를 5점으로 설정함	정책 제안 건수*1 + 공공교육 개최 건수*0.8 + 국내외 행사(심포지움, 학회 등) 개최 건수*0.5 + 간행물 발간 및 기고 건수*0.5 + 연구 결과 발표(포스터, 발표, 논문 등)*0.8 + 언론 보도(뉴스 및 보도자료 등) 건수*1	정책 제안서, 공공교육 및 국제행사 안내 자료, 국내외 행사(심포지움, 학회) 참석자료, 간행물, 연구 결과, 언론홍보 공문 및 관련 자료 등
	실적	10.3	22.8	16.8	-	-			
	달성도	343.3	760.0	336.0	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	- 인공지능 기법을 활용한 질병 예측, 질환 원인 변이 발굴 및 뇌영상 연구용 데이터 구축을 위한 내부 연구 개시(’22.1) - 심부전, 노쇠 예방을 위한 디지털 헬스케어 연구, 웨어러블 기기 효율성 분석 연구, 인공지능 파이프라인 구축 연구 추진(’22.1분기) - 임신성 당뇨 관리 체계, 만성폐쇄성폐질환에 대한 디지털 헬스케어 기술 적용 연구, 헬스케어 인공지능 교육 운영, 인공지능 연구를 위한 윤리 지침 마련 연구 추진(’22.2분기) - 헬스케어인공지능 분야별 전문가 세미나 개최 14회(’22.6~’22.9) - 헬스케어 인공지능 연구개발 로드맵 구축(’22.3분기) - 헬스케어 인공지능 연구윤리 국제컨퍼런스 개최(’22.8) - 헬스케어 데이터의 활용을 위한 인공지능 교육 8강좌 운영(’22.9~’23.1) - 디지털 트윈을 이용한 ROR 연구 추진(’22.4분기) - 디지털 헬스케어 및 의료 인공지능 전문가 자문회의 2회 개최(’22.10, ’22.12)

	- 디지털 헬스케어 및 의료 인공지능 전문가 Focus Group Interview(FGI) 4회 개최('22.11) - 헬스케어 인공지능 연구윤리 교육 세미나 개최('22.12) - 특허 1건 출원('22.) ・(특허) 객관적 감정 분석 기반의 감정 피드백 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램(국내출원)
2023	- 인공지능 기법을 활용한 질병 예측, 질환 원인 변이 발굴 및 뇌영상 연구용 데이터 구축을 위한 내부 연구 지속 추진('23.1) - 2023 한국유전체학회 동계 심포지엄 세션 [Application of multiomics study on COVID-19] 운영('23.2) - 디지털 헬스케어 기술을 활용하여 임신성 당뇨, 노쇠, 심부전, 만성폐쇄성폐질환 환자들의 건강 관리를 위한 연구 추진('23.2) - 헬스케어·인공지능 연구개발 중장기 로드맵 구축('23.3) - '헬스케어 인공지능 연구의 윤리지침 개발과 교육 방안' 공청회 개최('23.4) - 디지털 기술을 접목한 양방향 소통 코호트 관리 모델 개발 연구 추진('23.7) - IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) 학회 세션 [The role of the nationwide data collection and lifelog for healthcare] 운영('23.7) - '보건의료 분야 인공지능 연구윤리 지침' 발간 및 보도참고자료 배포('23.8) - 대한의용생체공학회 2023년도 추계학술대회 세션 [AI/ML for Healthcare Data Science] 운영('23.11) - 한국생명정보학회 BIOINFO 2023 세션 [How to use public DB for Bioinformatics] 운영('23.11) - 논문 5건 게재 및 특허 1건 출원('23.) ・(논문) A prognostic model for classification of COVID-19 severity based on clinical and laboratory testing data(IEEE BigComp, IF 1.65) ・(논문) Recent Prevalence of and Factors Associated With Chronic Obstructive Pulmonary Disease in a Rapidly Aging Society: Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2015-2019(Journal of Korean Medical Science, IF 4.5, mrnIF 72.024) ('23.4) ・(논문) Digital Health Technology Use Among Older Adults: Exploring the Impact of Frailty on Utilization, Purpose, and Satisfaction in Korea(Journal of Korean medical science, SCI, IF 4.5. mrnIF 72.024) ・(논문) 보건의료 분야 인공지능 연구자를 위한 연구윤리 지침 개발(한국의료법학회지, IF 0.93) ('23.6) ・(논문) 헬스케어 인공지능에서 악을 식별할 수 있을까: 플로리디 정보 윤리학에 기초하여(생명윤리, IF 0.84) ('23.12) ・(특허) 임신 당뇨병 관리장치 (국내출원, 10-2023-0145040) ('23.11)

2024	- 2024 한국유전체학회 동계 심포지엄 세션 운영 [Genomic Exploration and Precision Medicine: Multimodal Data Utilization of KNIH]('24.2) - '보건의료 분야 인공지능 연구 윤리 지침' 영문본 [Research Ethics Guidelines for Healthcare AI Researchers] 발간 ('24.6) - '국외 뇌영상 공개 데이터베이스 소개 및 활용' 안내서 발간('24.6) - 논문 9건 게재 및 특허 6건 출원/2건 등록('24.) · (논문) Developing a Framework for Self regulatory Governance in Healthcare AI Research: Insights from South Korea(Asian Bioethics Review, IF 1.3, mrnIF 99.589 '24.3) · (논문) Demand and Requirements for a Digital Healthcare System to Manage Gestational Diabetes in Patients and Healthcare Professionals: A Cross-sectional Survey(INQUIRY, IF 1.7, mrnIF 26.43, '24.5) · (논문) Comparative Analysis of Gait Speed Measurement Protocols: Static Start Versus Dynamic Start in a Cross-Sectional Study Using Light Detection and Ranging(The Journal of Frailty & Aging, IF 3.3, mrnIF 53, '24.5) · (논문) 헬스케어 AI 윤리에서 환자·시민 참여 모형: 주제범위 고찰과 방법론적 검토에 기초하여(KJME, '24.5) · (논문) Denoiseit: denoising gene expression data using rank based isolation trees (BMC Bioinformatics, IF 2.9, mrnIF 61.905, '24.8) · (논문) Disease progression associated cytokines in COVID-19 patients with deteriorating and recovering health conditions(Scientific Reports, IF 3.8, mrnIF 81.955, '24.10) · (논문) Angiotensin receptor-neprilysin inhibitor adherence and outcomes in heart failure with reduced ejection fraction, Obesity and heart failure with preserved ejection fraction: focus on the new drugs and future direction in medical treatment(esc heart failure, IF 3.2, '24.10) · (논문) Immunopathological markers and cell types linked to COVID-19 symptom manifestation(BMC Infectious Diseases, IF 3.4, mrnIF 64.122, '24.11) · (논문) Fusion of Multiple Self-Diagnostic Questionnaires into Optimal Diagnostic Cut-offs and Factor Analysis for Depression Characterization of the Korean University Student Group(BMC Psychiatry, mrnIF 73.83, '24.11) · (특허) 운동 능력 파라미터들에 기초한 노쇠 정도 측정기 (국외 출원 18/634465 '24.4 / 국외 등록 16/979825 '24.5) · (특허) 보행 속도에 기초한 노쇠 정도 측정기 (국내 출원 10-2024-0013344 '24.1 / 국내 등록 10-2632520 '24.1) · (특허) 임신성 당뇨병 추적관리 장치 및 방법 (국내 출원 10-2024-0093744 '24.7)

	·(특허) 시계열 멀티오믹스 통합분석 및 인공지능 활용 연구 (국내 출원 10-2024-0130658 ’24.9) ·(특허) 움직임 정보에 기초한 심폐 기능 지표 측정지(국내 출원 2024-0114815 ‘24.8) ·(특허) 심부전 환자 중재시스템과 방법 및 이를 위한 컴퓨터 프로그램(국내 출원 10-2024-0151112 ‘24.10)
2025	- 2025 한국유전체학회 동계 심포지엄 세션 운영 [Genomics and Immunology: From Technology to Translational Insights](‘25.2) - 2025 BIOKOREA 세션 운영 [국립보건연구원 보유 헬스케어 데이터를 활용한 인공지능 연구사례 공유](‘25.5) - ‘분산형 임상연구 동향 및 활용 안내서’ 안내서 발간(‘25.6) - ‘공개 라이프로그 데이터베이스 소개 및 활용’ 안내서 발간(‘25.6) - 헬스케어 분야 인공지능 활용 기업 정책간담회 개체(‘25.7) - ‘비정형 의료 데이터 정제 및 표준화 가이드라인’ 안내서 발간(‘25.10) - 2025 한국생명정보학회 세션 운영 [Artificial Intelligence in Spatial Omics:Bridging digital pthology and spatial transcriptomics](‘25.10) - 2025 대한의료정보학회 추계학술대회 세션 운영 [라이프로그 기반 건강 예측 연구 사례](‘25.11) - 논문 20건 게재 및 특허 9건 출원/등록(‘25.) ·(논문) EpicPrd: Predicting phenotypes driven by epitope binding TCRs using attention-based multiple instance learning (Bioinformatics, IF 4.4, mrnIF 90.769, ’25.2) ·(논문) ExPDrug: Integration of an interpretable neural network and knowledge graph for pathway-based drug repurposing (Computers in Biology and Medicine, IF 7, mrnIF 89.349, ’25.3) ·(논문) B cell-reactive neoantigens boost antitumor immunity (Science Advances, IF 12.5, mrnIF 91.852, ’25.3) ·(논문) Participant adherence in Repeated-Dose Clinical Studies using Video-Based Observation: A Retrospective Data Analysis (JMIR mhealth uhealth, IF 5.4, mrnIF 94.22, ’25.4) ·(논문) Video-estimated peak jump power using deep learning is associated with sarcopenia and low physical performance in adults (Osteoporosis International, IF 5.4, mrnIF 83.854, ’25.5) ·(논문) Low household income and income volatility increase risk of lung cancer: A nationwide retrospective cohort study (Cancer communications, IF 24.9, mrnIF 94.3, ’25.6) ·(논문) Profiling Short-Term Longitudinal Severity Progression and Associated Genes in COVID-19 Patients Using EHR and Single-Cell Analysis (Scientific Reports , IF 3.8, mrnIF 91.955, ’25.7)

	· (논문) Analyzing Diagnostic Reasoning of Vision–Language Models via Zero-Shot Chain-of-Thought Prompting in Medical Visual Question Answering (Mathematics, IF 2.2, mrnIF 94.094, '25.7) · (논문) Predicting sleep quality with digital biomarkers and artificial neural networks (Frontiers in Phychiatry, IF 3.2, mrnIF 68.641, '25.7) · (논문) SynchDP: A Correlation Based Sequence Alignment Algorithm for Synchronizing Longitudinal Clinical Data (Computers in Biology and Medicine, IF 6.3, mrnIF 94.34, '25.8) · (논문) A review on multi-omics integration for aiding study design of large scale TCGA cancer dataset (Computers in Biology and Medicine, IF 3.7, mrnIF 73.298, '25.8) · (논문) A continuous real-world dataset comprising wearable-based heart rate variability alongside sleep diaries (Scientific Data, IF 6.9, mrnIF 89.63, '25.8) · (논문) Identification of Severity Related Mutation Hotspots in SARS-CoV-2 Using a Density-Based Clustering Approach (BioData Mining, IF 6.1, mrnIF 93.939, '25.9) · (논문) RAMHA: A Hybrid Social Text-Based Transformer with Adapter for Mental Health Emotion Classification (Mathematics, IF 2.2, mrnIF 94.094, '25.9) · (논문) Multi-institutional validation of AI models for classifying urothelial neoplasms in digital pathology (Scientific Reports, IF 3.9, mrnIF 70, '25.10) · (논문) A machine learning framework for classifying dementia risk in mild cognitive impairment: evidence from a Korean genome-wide association study cohort (Alzheimer's Research & Therapy, IF 7.6, mrnIF 93.684, '25.11) · (논문) TSCytoPred : Inferring time-series cytokine expression for transcriptomics data based on deep learning (PeerJ, IF 2.4, mrnIF 65.926, '25.11) · (논문) Domain and Language Adaptive Pre-training of BERT Models for Korean-English Bilingual Clinical Text Analysis (BMC Medical Informatics and Decision Making, IF 3.8, mrnIF 61.7, '25.11) · (논문) Heart disease prediction using hybrid TabNet architecture with stacked ensemble learning (Frontiers in Physiology, IF 3.4, mrnIF 68.641, '25.11) · (논문) Secretory IgA dysfunction underlies poor prognosis in Fusobacterium-infected colorectal cancer (Gut Microbes, IF 12.3, mrnIF 94.444, '25.12)

	·(특허) 건강 상태 진단을 위한 영역 설정 방법 및 장치 (국내 출원 10-2025-0043561 '25.4) ·(특허) 의료 데이터를 사용자 정의 규칙 기반으로 비식별화하는 방법 및 장치 (국내 출원 10-2025-0059300 '25.5) ·(특허) Apparatus for Measuring Degree of Frailty on Basis of Atheletic Ability Parameters (분할출원) (국외 출원 19/219,712 '25.5) ·(특허) 生体情報及 基 指標 予 びライフログデータに づくリアルタイムのフレイル の 測方法及 裝置 (국외 출원 2025-540727 '25.7) ·(특허) METHOD AND APPARATUS FOR REAL-TIME FRAILTY INDEX PREDICTION BASED ON BIOMETRIC AND LIFELOG DATA (국외 출원 19/297,353 '25.8) ·(특허) 모션 기반 노쇠 정도 예측 방법, 장치 및 시스템 (국내 출원 10-2025-0133774 '25.9) ·(특허) 보행 속도에 기초한 노쇠 정도 측정기(분할출원) (국내 출원 10-2025-0154843 '25.10) ·(특허) 한영 이중언어 의료 코퍼스 기반 딥러닝 자연어처리 시스템 및 그 방법 (국내 출원 10-2025-0173653 '25.11) ·(특허) 거대 언어 모델을 활용한 인공지능 기반의 유전변이 해석 지원 시스템 및 그 방법 (국내 출원 10-2025-0185299 '25.11)

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 헬스케어 분야 데이터를 기반으로 개발된 인공지능 기법을 의료 현장에 적용 확대
- 인공지능 기법의 정확도 개선을 위한 신규 대규모 연구용 데이터 세트 지속 제공
- 질병관리청 고유사업에서 수집된 연구용 헬스케어 데이터 공개 확대
- 코호트 기반 학습용 데이터를 활용한 인공지능 연구 및 교육 지원체계 마련
- 'AI 헬스케어' 협업 사업을 통한 인공지능 학습용 데이터 공유·지원
- 대규모 컴퓨팅 인공지능 기법 마련을 통한 연구기관 및 산업계 지원체계 마련

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

○ (내역별 공통)

- 헬스케어 연구데이터 인공지능 활용: 내부연구과제와 연구용역과제로 구성
- 인공지능 연구지원 : 연구용역과제로 구성

추진절차	내부연구과제	연구용역과제
계획 수립	○과제제안근거, 제안서, 유사과제 검색결과 등 계획 수립	○과제제안근거, 제안서, 유사과제 검색결과 등 계획 수립
⇩		
선정 평가 등 과제 확정	○기획자문위원회 및 분야별 전문위원회 심의를 통한 선정평가 대상과제 결정 ○과제 선정평가 ○과제 확정	○기획자문위원회 및 분야별 전문위원회 심의를 통한 과제 확정 ○공고/응모 접수 ○응모기관 선정평가 ○계약 체결
⇩		
진도관리	○연차실적계획서 점검 * 필요한 경우 특별평가 실시	○중간진도보고서 자체점검 ○연차실적계획서 점검 및 검사 * 필요한 경우 특별평가 실시
⇩		
최종평가	○(종료과제) 최종평가	○(종료과제) 최종평가
⇩		
성과관리	○연구정보 NTIS 등록 ○연구종료 후 5년간 성과활용 추적 관리	○연구정보 NTIS 등록 ○연구종료 후 5년간 성과활용 추적 관리

※ 동 사업은 질병관리청 국립보건연구원 연구개발과제 관리지침에 따라 수행

- (내부과제) 질병관리청의 R&D 예산으로 청 내에서 자체 수행하는 연구과제
- (학술용역) 사업추진을 위해 국내・외 대학, 연구기관, 기업 등 외부기관에 연구개발비 예산으로 발주하는 연구과제

8) 각종 평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이.전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액 (예상)	불용액 (예상)
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2022	3,000	-	3,000	-	△14	-	2,986	1,998	66.6	66.9	464	524
2023	2,724	-	2,724	464	△163	-	3,025	2,825	103.7	93.4	60	140
2024	5,012	-	5,012	60	-	-	5,072	4,564	91.1	90.0	48	460
2025. 12월 말	4,932	-	4,932	48			4,980	4,904	99.4	98.5	-	76

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- (내역변경) ‘전국단위 대규모 항체양성률 조사’를 위해 ‘신기술 기반 백신플랫폼 개발지원’ 사업으로 14백만원 이용 - (이월) 용역 계약기간 미도래로 인한 464백만원 이월 - (불용) 신규 인력 채용 지연으로 인한 인건비 318백만원, 용역 낙찰차액 및 집행잔액 206백만원 불용
2023	- (전용) ‘예산 및 기금운용계획 집행지침’에 따라 학술·평가 및 임상연구 등 용역 수행을 위해 168백만원 전용 - (이용) ‘코로나19 격리입원치료비 지원’사업 예산 부족분 충당을 위해 163백만원 이용 - (이월) 용역 계약기간 미도래로 인한 60백만원 이월 - (불용) 용역 낙찰차액 및 집행잔액 등 125백만원 및 인건비 잔액 15백만원 불용
2024	- (이월) 연구용역 잔금 48백만원 이월 - (불용) 용역 미집행금액 및 낙찰차액 337백만원 및 인건비 등 집행 잔액 123백만원 불용
2025	- 해당없음

□ 2025년 이・전용 등 세부내역 : 해당없음